SDD 22 Sujet n°1

Spécialité : Néphrologie

Date : 31/12/2024
Auteur : MOKHTARI Schéhérazade (EDN 2024)
Relecteurs : RUBIN Hélène (EDN 2024), VILLARD Sébastien (ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Examen clinique Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Items en lien avec la station	261 – Néphropathie glomérulaire 348 – Insuffisance rénale aiguë / anurie
Situation de départ en lien avec la station	SDD 022 - diminution de la diurèse
Matériel nécessaire à la station	Bilan biologique
Contexte de la station	Bureau médical des urgences

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne aux urgences.
Vous recevez M Z, âgé de 28 ans qui s'inquiète de moins uriner depuis hier soir. La diurèse est estimée à environ 250 mL en 24h (soit 0,15 mL/kg/h).

Votre super-externe est déjà allé le voir pour réaliser son anamnèse, son examen clinique et a regardé son bilan biologique.
Il a pour antécédents notables un rein unique congénital sans insuffisance rénale chronique, et une angine non traitée il y a 3 semaines. Le patient ne prend aucun traitement, notamment pas d'AINS ni de diurétique.

Consignes :
Vous devez :
- Demander à l'externe les éléments de l'examen clinique pour comprendre cette diminution de la diurèse.
- Lui énoncer les examens complémentaires que vous souhaitez prescrire.
- Réaliser une synthèse des résultats des examens complémentaires qui vous seront communiqués.

Vous ne devez pas :
- Rechercher les antécédents ou le mode de vie du patient.
- Vous adresser à un patient fictif (station avec PSS, sans PS)
- Expliquer la prise en charge thérapeutique.
- Rédiger une ordonnance.

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Demande les paramètres vitaux du patient pour éliminer un état de choc : pression artérielle ***ET*** fréquence cardiaque.	1pt	☐
2.	Demande si le patient présente un globe vésical pour éliminer une rétention aiguë d'urine.	1 pt	☐
3.	Recherche **au moins 1** signe de déshydratation extra-cellulaire : - Pli cutané - Perte de poids récente - Tachycardie	1pt	☐
4.	Recherche **au moins 2** signes de surcharges hydrosodée : - Œdèmes des membres inférieurs (ou déclives) - Turgescence jugulaire ou reflux hépato-jugulaire - Crépitants des bases ou diminution du murmure vésiculaire à l'auscultation pulmonaire - Prise de poids récente	1pt	☐
5.	Demande une biologie avec une créatininémie ***ET*** un ionogramme sanguin ***ET*** un ionogramme urinaire	1pt	☐
6.	Décrit une insuffisance rénale aiguë devant une valeur de créatininémie à 400 µmol/L.	1pt	☐
7.	Recherche une cause obstructive à cette IRA : échographie rénale et des voies urinaires ***ou*** échographie réno-vésicale.	1pt	☐
8.	Explique que l'IRA est de profil organique car le rapport Na/K est > 1 ***ou*** le rapport Urée plasmatique / Créatininémie < 50 µmol/L ***ou*** la FE de l'urée est > 40%.	1pt	☐
9.	Demande une bandelette urinaire ***ou*** un ECBU.	1pt	☐
10.	Décrit une hématurie microscopique sur l'ECBU.	1pt	☐
11.	Décrit une protéinurie de profil glomérulaire sur l'ECBU car supérieure à 1 g/g ou g/24h ***ou*** 100 mg/mmol ET que cette protéinurie est majoritairement composée d'albumine.	1pt	☐
12.	Demande l'albuminémie.	1pt	☐

13.	Réalise une synthèse des examens paracliniques : **insuffisance rénale aiguë** de profil **organique**, d'origine probablement **glomérulaire** associée à une **hématurie microscopique** (tous les éléments en gras sont nécessaires à l'obtention des points)	1pt	☐

Communications et attitudes

5. COMMUNICATION NON VERBALE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Se comporte de manière inappropriée (p. ex. ne regarde pas son interlocuteur, se comporte de manière offensante ou agressante) ou porte des jugements	Tente d'établir un contact visuel. Présente les difficultés à établir la conversation (p.ex. priorise l'accomplissement de la tâche clinique) et cela peut induire la frustration du patient/pair	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Établit la conversation	Regarde le patient/ pair la majeure partie du temps Est attentif aux indices du patient/pair et réagit de manière appropriée par son comportement/gestes.	Montre une bonne maîtrise de ses comportements et cherche à les adapter afin de favoriser la conversation /établir une relation.

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL sur 16 points	**/ points**

Notes pour la correction :

Dans une station sur une diminution de diurèse :

- Toujours éliminer le diagnostic différentiel : la rétention aiguë d'urines (recherche d'un globe vésical et +/- un bladder scan si doute)
- Éliminer des signes de gravité en demandant les paramètre vitaux : patient en état de choc ?
- Rechercher une insuffisance rénale aiguë par dosage de la créatininémie.

Le reste de la station rejoint l'algorithme diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë, avec :

- Elimination d'une origine obstructive par l'imagerie réno-vésicale
- Ionogramme sanguin ET urinaire pour différencier une origine fonctionnelle ou organique

Tableau 4 : **Indices plasmatiques et urinaires permettant de distinguer IRA F et IRA organiques (NTA)**

Signes	IRA F	NTA
Urée/Créatinine P (en µmol/L)	> 100	< 50
Na^+ U	< 20 mmol//L (si absence de diurétiques)	> 40 mmol/L
FE Na^+	< 1 % (si absence de diurétiques)	> 1-2 %
FE urée (utile si diurétiques)	< 35 %	> 35-40 %
Na^+/K^+ urinaire	< 1	> 1
U/P urée	> 10	< 10
U/P créatinine	> 30	< 30

FE Na^+ : fraction d'excrétion du sodium : ClNa/Clcr = (UNa/PNa)/(Ucr/Pcr) x 100

FE urée : fraction d'excrétion de l'urée : ClUrée/Clcr = (UUrée/PUrée)/(Ucr/Pcr) x 100

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ OU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

Consignes génériques pour le patient ou PSS :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat (contexte de la station) :

Vous êtes externe aux urgences, et vous êtes déjà allé voir Mr Z, 28 ans, pour réaliser son anamnèse, son examen clinique et récupéré les examens paracliniques.
Le patient présente une diminution de la diurèse depuis hier soir.
Il a pour antécédent un rein unique congénital, et une angine non traitée il y a 3 semaines.

Phrase de démarrage du patient simulé ou du PSS :

Salut, je viens de voir Mr Z, qui vient car il urine moins depuis hier.
Je suis allé faire son examen clinique et j'ai regardé les examens complémentaires.

Identité du patient :

Mr Tom Z. 28 ans, 1m80 pour 70kg. IMC à 21,6

Mode de vie :

Dentiste.
Célibataire sans enfant.
Pratique de la natation
Pas de tabac, pas d'OH

Antécédents personnels :

Rein unique congénital
Angine non traitée il y a 2 semaines

Antécédents familiaux :

Aucun connu.

Médicaments :

Aucun, notamment pas de prise d'AINS, pas d'injection de produit de contraste. Pas de diurétiques.

Allergie :

Aucune

Symptômes et signes physiques positifs : à ne donner que si demandé (un par un)

- OMI jusqu'à mi-mollet (également dire spontanément que le patient est surpris car c'est arrivé rapidement en quelques jours)
- Légers crépitants des bases de manière bilatérale sans autre bruit surajouté.
- Prise de 3 kg en moins d'une semaine

Symptômes et signes physiques négatifs :

- Absence de pli cutané
- Absence de perte de poids
- Absence de vertiges ou de crampes, pas de céphalées.
- Absence de dyspnée

Mode d'apparition, ancienneté et évolution des symptômes :

Angine il y a 3 semaines. 15 jours après, apparition rapidement progressive des œdèmes en 3-4 jours.

Paramètres vitaux :

- HTA = 178 /96 mmHg
- FC = 90 bpm
- Sat 02 = 97 % en air ambiant
- FR = 18 /min

Données complémentaires :

Quand demande une échographie rénale et/ou des voies urinaires
=> indiquer qu'il n'y a pas d'obstruction

Si l'étudiant demande une BU
=> dire "elle est faite, qu'est-ce que tu cherches dessus ?" :
- si demande la Protéinurie : dire "3 croix"
- si demande l'hématurie : "1 croix"

Si l'étudiant demande un **ECBU** et ses résultats, lui tendre l'annexe ECBU.
=> si l'étudiant ne décrit pas les résultats, lui demander "est ce que tu peux m'expliquer les résultats ?"

Si l'étudiant demande un **Ionogramme sanguin**, lui tendre l'annexe Ionogramme sanguin
=> si l'étudiant ne décrit pas les résultats, lui demander "est ce que tu peux m'expliquer les résultats ?"

Si l'étudiant demande un **Ionogramme urinaire**, lui tendre l'annexe Ionogramme urinaire
=> si l'étudiant ne décrit pas les résultats, lui demander "est ce que tu peux m'expliquer les résultats ?"

A 2 minutes de la fin, si l'étudiant n'a pas demandé tous les examens complémentaires/bilans biologiques, lui donner les fiches correspondantes.

Questions de relance :

A une minute de la fin de la station, si l'étudiant n'a pas évoqué le diagnostic le plus probable, lui demander "est ce que tu as une idée de pourquoi le patient urine moins ?"